Université de Constantine 3
Faculté de Médecine
Département de médecine
Examen de l'unité thématique d'enseignement en pharmacologie

Durée : Une heure **Veuillez cocher la ou les propositions justes**

1. Concernant l'absorption des médicaments, quelle est (sont) la (les) proposition(s) juste(s) parmi ce qui suit :

a) Elle peut être limitée par un effet de premier passage hépatique.
b) Elle peut être quantifiée par la clairance.
c) La modification du transit intestinal n'a pas d'influence sur l'absorption des médicaments administrés par voie orale.
d) Le risque d'interaction est plus important pour les médicaments absorbés via un mécanisme de transport actif.
e) La diffusion passive est un phénomène saturable.

2. Lors de l'élimination rénale des médicaments, la filtration glomérulaire :

a) Est un phénomène actif.
b) Est saturable.
c) Se fait par le biais de transporteurs spécifiques.
d) Peut faire l'objet d'un phénomène de compétition.
e) Toutes les réponses sont fausses.

3. Les interactions médicamenteuses en phase de métabolisme :

a) Sont représentées par l'induction enzymatique qui entraine une diminution du métabolisme hépatique.
b) Peuvent entrainer un échec thérapeutique.
c) Sont représentés par l'inhibition enzymatique qui entraine une accélération du métabolisme hépatique.
d) Peuvent entrainer un surdosage.
e) Sont toujours pertinentes sur le plan clinique.

4. La prescription des médicaments de la liste II :

a) Peut se faire par la DCI ou par le nom commercial.
b) Se fait sur une ordonnance extraite d'un carnet à souche.
c) Doit mentionner les coordonnées du prescripteur.
d) Doit mentionner la posologie des médicaments en toutes lettres.
e) La durée maximale de prescription est de 28 jours.

5. Concernant la prescription des psychotropes :

a) Se fait sur une ordonnance classique.
b) La durée maximale de prescription est de 12 semaines pour les anxiolytiques.
c) La durée de validité de l'ordonnance ne peut excéder 3 mois.
d) Tout médecin doit enregistrer ces prescriptions sur un registre spécial conservé pendant une année.
e) La posologie doit être indiquée en toutes lettres lisibles.

6. L'ordonnance :

a) Est un document légal rédigé obligatoirement par un médecin.
b) Comporte l'identification du traitement en DCI obligatoirement.
c) Peut comporter d'autres prescriptions que celles des médicaments (soins infirmiers et paramédicaux, examens complémentaires…).
d) Comporte des mentions pharmacologiques comme la posologie.
e) Comporte des mentions réglementaires comme le nom et le prénom du patient.

univ.ency-education.com

7. Les tétracyclines :

a) Agissent en inhibant la synthèse de l'acide nucléique bactérien.
b) Agissent en inhibant la synthèse protéique par action sur la sous-unité 30S du ribosome.
c) Peuvent entrainer une dyschromie dentaire chez les enfants de moins de 8 ans.
d) Ont un spectre d'activité étroit.
e) Diffusent mal dans les tissus.

8. Les phénicolés :

a) Agissent sur la sous-unité 30S du ribosome.
b) Sont bactéricides.
c) Peuvent entrainer une toxicité médullaire.
d) Peuvent entrainer une photosensibilisation.
e) Sont utilisés surtout par voie topique.

9. Les aminosides :

a) Ont comme cible principale la sous-unité 30S du ribosome.
b) Sont actifs sur les bactéries anaérobies strictes.
c) Ont une bonne biodisponibilité par voie orale.
d) Sont des antibiotiques de choix en cas d'infections nosocomiales sévères.
e) Peuvent entrainer des troubles auditifs.

10. Concernant l'association Cisapride + azythromycine :

a) Il s'agit d'une contre-indication relative
b) Il s'agit d'une contre-indication absolue
c) L'objectif thérapeutique est d'augmenter la sécurité de l'Acénocoumarol
d) L'objectif thérapeutique est de diminuer le coût de l'Acénocoumarol
e) L'érythromycine est un inhibiteur enzymatique

11. Concernant les caractéristiques de l'antagonisme fonctionnel :

a) L'agoniste et l'antagoniste se fixent sur le même endroit du récepteur
b) L'agoniste et l'antagoniste se fixent sur le même récepteur au niveau de sites différents
c) Il peut se produire lors de l'association d'un β bloquant non cardiosélectif et d'un β2 mimétique
d) Il peut survenir lors de l'association du salbutamol et de la terbutaline
c) On peut restaurer l'effet de l'agoniste par l'augmentation de la concentration de l'antagoniste

12. Concernant les caractéristiques de l'antagonisme non compétitif :

a) L'agoniste peut donner 100% d'effet en présence de l'antagoniste
b) La concentration efficace 50 diminue
c) Le PD2 augmente
d) La puissance de l'agoniste diminue
e) L'affinité de l'agoniste pour le récepteur augmente

13. Les récepteur β1 adrénergiques :

a) Sont couplés à la protéine Gs
b) Sont couplés à la protéine Gi
c) Leur activation entraine la diminution du calcium intracellulaire
d) Leur stimulation entraine l'inactivation de la Protéine kinase A
e) Leur stimulation entraine un effet dromotrope positif

14. Concernant le récepteur des stéroïdes :

a) C'est un récepteur membranaire à activité enzymatique
b) C'est un récepteur membranaire couplé à la protéine Gs
c) La régulation positive augmente la synthèse des protéines anti-inflammatoires
d) La régulation négative diminue la synthèse des protéines inflammatoires
e) Sans ligand le récepteur se dissocie des protéines HSP.

univ.ency-education.com

15. Concernant les agonistes β 2 adrénergiques :

a) Le salbutamol en est un exemple.
b) Ils peuvent être utilisés dans le traitement de l'asthme.
c) Ils entrainent une bronchodilatation
d) Ils ont un effet ocytocique
e) Ils peuvent avoir comme effet indésirables une glycogénolyse.

16. Le propranolol :

a) Est un β bloquant liposoluble
b) Est indiqué dans l'insuffisance cardiaque congestive
c) Possède un effet β agoniste partiel au repos
d) Possède une sélectivité β1 relative et dose dépendante
e) Est pourvu d'un effet stabilisateur de la membrane

17. Carbidopa et benséraside :

a) Sont des sympathomimétiques indirects
b) Exercent une action périphérique uniquement
c) Inhibent la dopadécarboxylase au niveau du système nerveux central
d) Sont des antiparkinsoniens directs
e) Sont des sympatholytiques indirects

18. La modélisation moléculaire :

a) Est une simulation des systèmes chimiques
b) N'est pas assistée par un ordinateur
c) Est faite avant l'identification de la cible
d) Nécessite la confirmation de l'activité pharmacologique en préalable
e) Vise la conception d'un pharmacophore

19. Les essais cliniques de phase I :

a) Permettent le dépistage des réactions d'intolérance
b) Permettent de mettre au point la forme galénique
c) Sont une étude pilote
d) Se font sur des groupes de sujets malades
e) Comprennent des groupes de 200 à 500 volontaires

20. Les essais cliniques de phase II :

a) Le nombre des volontaires dans la phase II_A est supérieur à la phase II_B
b) Ils se font sur des volontaires sains
c) Ils permettent de déterminer les interactions médicamenteuses
d) Déterminent la dose optimale en termes d'efficacité
e) Détectent les effets indésirables à long terme

21. Parmi les contre-indications des AINS

a) Ulcère gastroduodénal en évolution
b) Asthme
c) Insuffisance hépatocellulaire et rénale sévère
d) Dysménorrhée
e) Accidents ischémiques

22. Les antalgiques du palier II

a) Peuvent être associés aux antidépresseurs
b) Sont contre indiqués en cas d'insuffisance respiratoire
c) Peuvent être prescrits en cas de grossesse
d) Peuvent être associés au paracétamol
e) Provoquent nausées et somnolence

23. La buprénorphine

a) Est un agoniste parfait des récepteurs mu
b) Provoque une dépendance psychique plus importante que la morphine
c) La naloxone a un effet important sur elle
d) Est un traitement rapide et efficace d'une douleur intense
e) Produit un métabolite actif

24. L'effet Nocebo :

a) Se voit avec une forme médicamenteuse ne contenant aucune substance active
b) Est un effet bénéfique
c) Est un effet néfaste
d) Est un effet thérapeutique
e) N'existe pas

univ.ency-education.com

25. Les effets indésirables de type B :

a) Sont prévisibles
b) Sont imprévisibles
c) Dépendent de la posologie
d) Ne dépendent pas de la posologie
e) Leur incidence est élevée

26. Parmi les effets suivants, les quels concernent une activité parasympathomimétique :

a) Bradycardie
b) Diminution de la sécrétion acide gastrique
c) Bronchoconstriction
d) Mydriase
e) Constipation

27. Tropicamide :

a) Est un parasympathomimétique
b) Est utilisé pour le traitement du glaucome
c) Est indiqué comme mydriatique en vue de l'examen de fond d'œil
d) Est un parasympatholytique
e) Est utilisé dans le traitement de l'asthme

28. Parmi les molécules suivantes, laquelle est indiquée en cas de glaucome :

a) Acéclidine
b) Tropicamide
c) Atropine
d) Tiemonium
e) Ipratropium

29. Si les doses orales et IV sont différentes, le calcul du facteur de biodisponibilité

a) Est impossible
b) Utilise seulement la valeur de la dose IV
c) Utilise la formule générale x l'inverse des doses
d) Utilise la formule générale inchangée
e) Utilise la formule générale x doses orale

30. Si la concentration plasmatique à la sortie de l'organe est égale à zéro

a) Le facteur d'extraction est nul
b) La clairance est nulle
c) Le facteur d'extraction peut être inférieur à 1
d) La clairance par l'organe est égale au débit de perfusion
e) La clairance par l'organe est égale à la clairance totale

31. La vitesse d'absorption d'un médicament impacte :

a) L'AUC
b) La concentration maximale
c) Le Tmax
d) Le volume de distribution
e) La clairance totale

32. L'effet post antibiotique

a) Permet d'inhiber plusieurs souches bactériennes
b) Permet d'augmenter la valeur de la CMI
c) Permet de réduire les doses l'antibiotique durant le traitement
d) Permet l'inhibition de la croissance bactrienne après élimination du médicament
e) Est une action antibiotique dépendante du temps

33. A quelle génération de céphalosporines appartient Céfuroxime ZINNAT®

a) 1 ére génération
b) 2 éme génération
c) 3 éme génération
d) 4 éme génération
e) 5 éme génération

34. Effets indésirables des beta bloquants :

a) Tachycardie
b) Hypertension
c) Bronchospasme
d) Insuffisance cardiaque
e) Syndrome de Raynaud

35. Effets indésirables des IEC :

a) Hypertension
b) Hypokaliémie
c) Toux sèche
d) Insuffisance rénale
e) Hypersensibilité

BON COURAGE
EQUIPE PHARMACOLOGIE

univ.ency-education.com

UNIVERSITE SALAH BOUBNIDER - Constantine 3
Faculté de médecine de Constantine

Département de Médecine de Constantine-Epreuve de PHARMACOLOGIE-A3-C1- RE LE 19-06-2023

Date de l'épreuve : 22/03/2023

Corrigé Type

Barême par question : 0,571429

N°	Rép.
1	AD
2	E
3	BD
4	AC
5	BC
6	CDE
7	BC
8	CE
9	ADE
10	BE
11	C
12	D
13	AE
14	CD
15	ABC
16	AE
17	BE
18	AE
19	AB
20	CD
21	ABC
22	BDE
23	DE
24	AC
25	BD
26	AC
27	CD
28	A
29	C
30	D
31	BC
32	D
33	B
34	CDE
35	CDE

univ.ency-education.com